



PUTUSAN
Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LAODE KUDU;**
2. Tempat lahir : Wakatobi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 29 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pada Raya Makmur Kec. Wangi - wangi
Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/220/VII/2024/Satreksrim tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Hakim sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Arifai, S.H., M.H., Aurelianiza, Agum Okto Prasetyo, S.H., dan Arif Setiawan Putra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara beralamat di Jalan Brigjen M. Joenoes Komp. Senapati Land AA.14 By-Pass-Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE KUDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE KUDU** selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan mengenakan tindakan terhadap Terdakwa dengan cara memasukkan terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk menjalani perawatan **selama 1 tahun** sampai dengan terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana keterangan dokter ahli kejiwaan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 38 (Tiga puluh delapan) Cm;
 - 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kuning terdapat darah yang mengering;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dalaman merah terdapat darah yang mengering;
 - 1 (satu) lembar singlet warna putih terdapat darah yang mengering;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar jaket motif loreng dan warna abu – abu pada bagian dalam terdapat darah yang mengering;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan satu dan kedua atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum, dan menyatakan tindakan yang diambil terhadap Terdakwa yaitu dengan memasukkan Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk menjalani perawatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-209/Eoh.2/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa LAODE KUDU (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Wakatobi menuju ke Kendari dan setibanya di Pelabuhan Nusantara Kendari, kemudian Terdakwa istirahat dan tidur di Pelabuhan Nusantara. Selanjutnya pada keesokan harinya, yakni pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WITA, Terdakwa bangun dan kemudian bertemu dengan korban Sdr. NARWIN (Alm) yang merupakan sopir mobil penumpang.
- 2- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa meminta kepada Sdr. NARWIN untuk mengantarnya ke Rumah Sakit Jiwa, sehingga terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dan Sdr. NARWIN dan sepakat biaya pengantarannya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Sdr. NAWIR.
- 3- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan, Terdakwa melihat jalan yang dilalui Sdr. NARWIN bukan merupakan jalan menuju Rumah Sakit Jiwa Kendari sehingga terjadi perdebatan mulut antara Terdakwa dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARWIN karena menurut Sdr. NARWIN, lokasi Rumah Sakit Jiwa sudah sesuai yakni berada di Jalan Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari sehingga Sdr. NARWIN berhenti di pinggir jalan dan meminta kepada Terdakwa untuk keluar dari mobil.

- 4- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari mobil, Sdr. NARWIN turun dari mobil dan memukul kepala Terdakwa menggunakan kayu sehingga Terdakwa merespons pukulan tersebut dengan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 38 (Tiga puluh delapan) Cm yang disimpan didalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut secara berulang kali sehingga mengenai tubuh Sdr. NARWIN dan mengakibatkan luka pada kepala, wajah, telinga dan anggota gerak, patah tulang atap tengkorak, tulang rahang bawah, tulang hasta kanan bawah, tulang telapak tangan kanan, tulang hasta dan pengumpil kiri, tulang telapak tangan kiri, tulang ibu jari tangan kiri, tulang pergelangan kaki kanan dan kiri, putusnya tendon, pembuluh darah dan saraf pergelangan tangan kiri dan kedua pergelangan kaki Sdr. NARWIN.
- 5- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi LAODE HARLIN dan Saksi MUH. DONI melihat dan membantu untuk mengamankan Terdakwa hingga pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian. Sedangkan Korban Sdr. NARWIN sudah tidak berdaya dan akhirnya meninggal ditempat sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor : B/15/VII/2024 tanggal 24 juli 2024 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa Dr. dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,MH,Sp.FM, MHPE, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang menerangkan benar bahwa Sdr. NARWIN telah dipastikan meninggal dunia sesuai pemeriksaan di ruang Kompartemen Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 09.30 WITA.
- 6- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 14/VII/2024/Forensik, tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,MH,Sp.FM, MHPE Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - A. Tanatologi Mayat :
 1. Lebam Mayat : Tidak ada.
 2. Kaku Mayat : Pada kelopak mata, rahang bawah, anggota gerak, dapat dilawan.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



3. Pembusukan : Tidak ada. –

B. Pemeriksaan luar :

1. Kepala :

a. Daerah berambut : Terdapat enam belas buah luka terbuka hampir pada seluruh permukaan kepala, sebelum dirapatkan bentuk menyerupai celah, setelah dirapatkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis lurus, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka tulang tengkorak, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak ada kelainan.

1) Luka pertama pada pertengahan kepala sisi depan di atas batas atas tumbuh rambut arah vertikal miring, ujung pertama satu sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tepat pada batas atas tumbuh rambut, ujung kedua tepat di garis tengah tubuh dan lima sentimeter diatas batas atas tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran delapan sentimeter.

2) Luka kedua pada pertengahan kepala sisi depan arah mendatar berpotongan tegak lurus dengan luka pertama, ujung pertama empat sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan satu sentimeter di atas batas atas tumbuh rambut, ujung kedua dua sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan satu sentimeter diatas batas atas tumbuh rambut sebelum dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang enam koma lima sentimeter.

3) Luka ketiga pada puncak kepala sisi samping kanan arah vertikal, ujung pertama lima sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan delapan sentimeter di atas batas bawah tumbuh rambut, ujung kedua tiga sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan delapan sentimeter di atas batas bawah tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang delapan sentimeter.

4) Luka keempat pada puncak kepala sisi samping kanan arah vertikal satu sentimeter di kanan luka ketiga, sebelum



dirapatkan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma sembilan sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter.

- 5) Luka kelima pada kepala sisi samping kanan ujung pertama dua belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan sembilan sentimeter di atas lubang telinga kanan arah mendatar, ujung kedua delapan belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter di atas lubang telinga kanan, sebelum dirapatkan ukuran panjang tujuh koma tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang delapan sentimeter.
- 6) Luka keenam pada kepala sisi samping kanan pada ujung pertama luka kelima arah vertikal miring, sebelum dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang enam koma lima sentimeter.
- 7) Luka ketujuh pada kepala sisi kiri arah vertikal, ujung pertama lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter diatas batas atas tumbuh rambut, ujung kedua lima koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter diatas batas atas tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tujuh sentimeter.
- 8) Luka kedelapan pada kepala belakang sisi kanan arah vertikal, ujung pertama dua koma lima sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan dua belas sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, ujung kedua dua koma delapan sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan lima sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tujuh sentimeter.
- 9) Luka kesembilan pada kepala belakang sisi kanan bawah arah miring. ujung pertama delapan sentimeter di kanan



garis tengah tubuh dan empat sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, ujung kedua lima sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan dua sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter.

10) Luka kesepuluh pada kepala belakang sisi kanan arah miring tegak lurus luka kesembilan, ujung pertama dua koma lima sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan lima sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, ujung kedua tiga koma lima sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang dua koma lima sentimeter.

11) Luka kesebelas pada kepala belakang sisi tengah arah miring ujung pertama dua sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan empat sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, ujung kedua dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan satu sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang lima koma lima sentimeter.

12) Luka keduabelas pada kepala belakang sisi kiri arah vertikal ujung pertama dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, ujung kedua dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan enam sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat koma lima sentimeter.

13) Luka ketigabelas pada kepala belakang sisi kiri arah miring ujung pertama tiga sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut,



ujung kedua lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan enam sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter.

14) Luka keempatbelas pada kepala belakang sisi kiri bawah arah mendatar ujung pertama dua sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, ujung kedua tujuh sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua koma tiga sentimeter diatas batas bawah tumbuh rambut, sebelum dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat koma lima sentimeter.

15) Luka kelimabelas pada kepala belakang sisi kiri bawah tepat diatas garis batas bawah tumbuh rambut arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tiga koma tujuh sentimeter.

16) Luka keenambelas pada kepala belakang sisi kanan bawah tepat dibawah garis batas bawah tumbuh rambut belakang telinga kanan arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat koma tiga sentimeter.

b. Wajah : Terdapat enam belas buah luka terbuka pada wajah, sebelum dirapatkan bentuk menyerupai celah, setelah dirapatkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis lurus, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak ada kelainan.

1) Luka pertama pada pertengahan pangkal dahi tepat di bawah garis batas atas tumbuh rambut arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tujuh sentimeter, dasar luka tulang tengkorak.



- 2) Luka kedua pada dahi sisi kanan arah mendatar, ujung pertama tujuh koma lima sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan empat sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua tepat di garis tengah tubuh dan tiga koma lima sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma tujuh sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang delapan sentimeter, dasar luka tulang tengkorak.
- 3) Luka ketiga pada dahi di atas pangkal hidung arah mendatar, ujung pertama tepat pada ujung alis kanan sisi dalam, ujung kedua tepat pada ujung luar alis kiri, sebelum dirapatkan Ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma ima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang delapan sentimeter, dasar luka tulang tengkorak.
- 4) Luka keempat pada pelipis kii arah mendatar, ujung pertama tepat pada ujung luar alis kiri, ujung kedua lima belas sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan empat sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang sebelas sentimeter, dasar luka tulang tengkorak.
- 5) Luka kelima pada pelipis kanan arah mendatar, ujung pertama delapan sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan lima sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan lima sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter, dasar luka tulang tengkorak.
- 6) Luka keenam pada pelipis kanan arah vertikal miring, ujung pertama sembilan sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tiga koma lima sentimeter di atas garis mendatar yang



melewati kedua mata, ujung kedua sebelas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan enam sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, dasar luka tulang tengkorak

- 7) Luka ketujuh pada dahi kanan tepat diatas ujung luar alis kanan hingga ujung pertama luka keenam arah miring, sebelum dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, dasar luka tulang tengkorak.
- 8) Luka kedelapan pada pipi kanan arah mendatar, ujung pertama tujuh sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tiga sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua tiga sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan empat sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma delapan sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang lima sentimeter, dasar luka tulang tengkorak.
- 9) Luka kesembilan pada pipi tepat di depan lubang telinga kanan, bentuk garis tidak lurus miring, ujung pertama tujuh belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tepat di garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan satu sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang dua koma tujuh sentimeter, dasar luka otot.
- 10) Luka kesepuluh pada pipi tepat di bawah luka kesembilan, bentuk garis tidak lurus miring ujung pertama tujuh belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam belas sentimeter di kanan garis



tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang dua koma tujuh sentimeter, dasar luka otot.

- 11) Luka kesebelas pada dagu kanan arah mendatar, ujung pertama sepuluh sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan delapan sentimeter di bawah garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua tujuh koma lima sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan delapan sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang dua koma tujuh sentimeter, dasar luka otot.
- 12) Luka duabelas pada dagu arah miring, ujung pertama di bawah sudut bibir kanan dan ujung kedua tepat di ujung tengah dagu, sebelum dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, dasar luka tulang rahang bawah.
- 13) Luka ketigabelas pada dagu arah mendatar memotong luka duabelas, ujung pertama dua koma lima sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua satu sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sepuluh koma lima sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, dasar luka tulang rahang bawah.
- 14) Luka keempatbelas pada dagu memotong luka ketigabelas ujung pertama pada pertengahan luka ketigabelas, ujung kedua dua koma lima sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dibawah garis mendatar yang melewati kedua mata, sebelum dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam



satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, dasar luka tulang rahang bawah.

15) Luka kelima belas pada daerah diantara hidung dan bibir atas sisi kanan arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, dasar luka jaringan ikat.

16) Luka keenambelas papa pipi kiri tepat dibawah kelopak mata bawah kiri sisi luar arah miring, sebelum dirapatkan ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, dasar luka jaringan ikat.

2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Bahu : Tidak ada kelainan.
4. Dada : Terdapat dua buah luka terbuka pada dada, sebelum dirapatkan bentuk menyerupai garis, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak ada kelainan.
 - a. Luka pertama pada dada kiri atas, ujung pertama tiga belas sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter diatas garis mendatar yang melwati kedua puting susu, ujung kedua empat sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan sembilan sentimeter diatas garismendatar yang melewati kedua puting susu, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter.
 - b. Luka kedua pada dada kanan atas ujung pertama dua belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua puting susu, ujung kedua Sembilan sentimeter dikanan garis tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis mendatar yang melewati kedua puting susu, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter.
5. Perut : Terdapat sebuah luka lecet pada perut kanan atas bentuk menyerupai garis arah mendatar, dengan titik pusat sembilan sentimeter dikanan garis tengah tubuh dan empat sentimeter diatas



garis mendatar yang melewati pusar, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

6. Punggung : Tidak ada kelainan.

7. Pinggang : Tidak ada kelainan.

8. Bokong : Tidak ada kelainan.

9. Anggota gerak atas :

a. Kanan :

1) Terdapat enam belas buah luka terbuka pada anggota gerak atas kanan, sebelum dirapatkan bentuk menyerupal colah, setelah dirapatkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis lurus, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak ada kelainan.

a) Luka pertama tepat pada siku kanan arah vertikal, sebelum dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, dasar luka tulang.

b) Luka kedua pada lengan bawah kanan sisi belakang arah mendatar, ujung pertama tujuh sentimeter di bawah siku, ujung kedua delapan sentimeter di bawah siku, sebelum dirapatkan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, dasar luka otot.

c) Luka ketiga pada lengan bawah kanan sisi belakang dalam arah miring, ujung pertama dua puluh sentimeter di bawah siku, ujung kedua dua puluh tiga sentimeter di bawah siku, sebelum dirapatkan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter, dasar luka tulang.

d) Luka keempat pada lengan bawah kanan sisi belakang hingga sisi dalam arah miring ujung pertama dua puluh dua sentimeter di bawah siku, ujung kedua dua puluh lima sentimeter di bawah siku, sebelum dirapatkan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar satu



sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang delapan sentimeter, dasar luka tulang.

- e) Luka kelima tepat pada pertengahan pergelangan tangan sisi belakang hingga punggung tangan kanan arah vertikal, sebelum dirapatkan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang sembilan sentimeter, dasar luka tulang.
- f) Luka keenam pada pergelangan tangan sisi luar dua sentimeter di sisi luar luka kelima arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter, dasar luka otot.
- g) Luka ketujuh pada pergelangan tangan sisi luar satu koma lima sentimeter di bawah luka keenam arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang dua koma dua sentimeter, dasar luka otot.
- h) Luka kedelapan pada pergelangan tangan sisi luar satu koma lima sentimeter di bawah luka ketujuh arah miring, sebelum dirapatkan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, setelah dirapatkan Ukuran panjang satu koma satu sentimeter, dasar luka jaringan ikat.
- i) Luka kesembilan pada punggung tangan satu sentimeter di sebelah dalam luka kelima arah vertikal, sebelum dirapatkan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
- j) Luka kesepuluh pada punggung tangan tepat pada pangkal jari telunjuk hingga pangkal jari tengah kanan arah miring, sebelum dirapatkan uuran parnjang tiga sentimeter, lebar nol koma enam sertimeter, dalam nol



- koma lima sertimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter, dasar luka tulang.
- k) Luka kesebelas pada punggung tangan tepat pada pangkal ibu jari kanan arah vertikal, sebelum dirapatkan ukuran panjang lima sertimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter, dasar luka tulang.
- l) Luka keduabelas pada ruas pertama jari manis kanan sisi belakang arah miring sebelum dirapatkan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sertimeter, dalam nol koma satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, dasar luka jaringan ikat.
- m) Luka ketigabelas pada ruas pertama jari kelingking kanan sisi belakang arah miring sebelum dirapatkan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatan ukuran panjang satu koma delapan sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- n) Luka keempatbelas pada ruas kedua jari telunjuk kanan sisi belakang arah miring sebelum dirapatkan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sertimeter, dalam nol koma satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, dasar luka jaringan ikat
- o) Luka kelimabelas pada ruas pertama jari kelingking kanan sisi belakang arah miring sebelum dirapatkan ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, dasar luka jaringan ikat.
- p) Luka keenambelas pada telapak tangan kanan sisi dalam dibawah jari kelingking arah miring, sebelum dirapatkan ukuran panjang lima sentimeler, lebar satu koma lima sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- 2) Jaringan dibawah kuku tampak pucat.



b. Kiri.

- 1) Terdapat sembilan buah luka terbuka pada anggota gerak atas kiri, sebelum dirapatkan bentuk menyerupai celah, setelah dirapatkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis lurus, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak ada kelainan.
 - a) Luka pertama melingkari pergelangan tangan kiri yang memutuskan lengan bawah dan tangan kiri diameter dua puluh lima sentimeter tampak otot, tendon, tulang, saraf dan pembuluh darah terpotong dan terpisah antara lengan dan tangan.
 - b) Luka kedua pada pertengahan punggung tangan kiri arah vertikal, sebelum dirapatkan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang sepuluh sentimeter, dasar luka tulang.
 - c) Luka ketiga pada punggung tangan kiri sisi dalam arah vertikal satu sentimeter di sisi dalam luka kedua, sebelum dirapatkan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
 - d) Luka keempat pada ruas pertama jari tengah kiri sisi belakang arah miring, sebelum dirapatkan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, dasar luka jaringan ikat.
 - e) Luka kelima pada ruas kedua jari telunjuk kiri sisi belakang arah miring, sebelum dirapatkan ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang satu koma satu sentimeter, dasar luka jaringan ikat.
 - f) Luka keenam pada ruas kedua ibu jari tangan kiri yang memutuskan ruas kedua dengan dan bagian ujung jari



yang berkuku arah miring, diameter tiga sentimeter
Tampak tendon, tulang, dan pembuluh darah terpotong
dan terpisah antara ruas ibu jari tangan kiri.

- g) Luka ketujuh pada kuku jari tengah kiri, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, dasar luka jaringan ikat.
- h) Luka kedelapan pada telapak tangan kiri sisi dalam dibawah jari telunjuk dan jari tengah arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, dasar luka jaringan otot.
- i) Luka kesembilan pada pangkal telapak tangan kiri berbatasan dengan telapak tangan arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang sebelas sentimeter, dasar luka jaringan otot.

2) Jaringan dibawah kuku tampak pucat.

10. Anggota gerak bawah :

a. Kanan :

- 1) Terdapat tiga buah luka terbuka pada anggota gerak bawah kanan, sebelum dirapatkan bentuk menyerupai celah, setelah dirapatkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis lurus, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak ada kelainan
 - a) Luka pertama pada pergelangan kaki kanan sisi dalam tepat di atas mata kaki sisi dalam arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam satu sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
 - b) Luka kedua pada pergelangan kaki kanan sisi belakang tepat sejajar mata kaki arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam dua sentimeter, setelah



dirapatkan ukuran panjang sepuluh sentimeter, dasar luka tulang otot. Tampak tendon otot betis terpotong

- c) Luka ketiga pada pergelangan kaki kanan ssatu koma lima sentimeter dibawah luka kedua arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua koma sentimeter, dalam dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tiga belas sentimeter, dasar luka tulang tulang Tampak tendon otot betis terpotong.

2) Jaringan dibawah kuku tampak pucat

b. Kiri.

- 1) Terdapat dua buah luka terbuka pada anggota gerak bawah kiri, sebelum dirapatkan bentuk menyerupai celah, setelah dirapatkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis lurus, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak ada kelainan.

a) Luka pertama pada pergelangan kaki kiri sisi belakang tepat sejajar mata kaki arah mendatar, sebelum dirapatkan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua koma sentimeter, dalam empat sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tiga belas sentimeter, dasar luka tulang tulang.

b) Luka kedua pada pergelangan kaki kiri sisi satu koma lima sentimeter di atas luka pertama yang kemudian bersatu dengan luka pertama pada sisi dalam, sebelum dirapatkan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, dasar luka tulang otot.

2) Jaringan dibawah kuku tampak pucat.

11. Bagian tubuh tertentu :

a. Mata :

- 1) Alis mata : Tidak ada kelainan
2) Kelopak mata :

a) Kanan : Terdapat sebuah luka terbuka pada pertemuan kelopak mata atas dan bawah kanan sisi luar arah mendatar hingga mengenai selaput kelopak mata, biji



mata, selaput bening mata, hingga isi bola mata kanan, sebelum dirapatkan bentuk menyerupai celah, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat dengan sempuma membentuk garis lurus ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dinding bola mata dan isi bola mata, dasar luka isi bola mata kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak ada kelainan.

- b) Kiri : Tidak ada kelainan.
- 3) Selaput kelopak mata :
 - a) Kanan : Sesuai luka pada kelopak mata
 - b) Kiri : Tidak ada Kelainan.
- 4) Selaput biji mata :
 - a) Kanan : Sesuai luka pada kelopak mata.
 - b) Kiri : Tidak ada Kelainan.
- 5) Selaput bening mata :
 - a) Kanan : Sesuai luka pada kelopak mata, Tampak lingkaran penuaan warna keabuan
 - b) Kiri : Tampak lingkaran penuaan warna keabuan.-
- 6) Manik Mata : Bentuk bundar, dengan diameter lima milimeter, kanan dan kiri, tidak ada kelainan.
- 7) Pelangi Mata : Warna cokelat, tidak ada kelainan.
- 8) Lensa mata : Tidak ada kelainan.
- b. Hidung :
 - 1) Bentuk hidung : Tidak ada kelainan.
 - 2) Permukaan hidung : Tidak ada kelainan.
 - 3) Lubang hidung : Tidak ada kelainan.
- c. Mulut :
 - 1) Bibir atas : Tampak kebiruan.
 - 2) Bibir bawah : Tampak Kebiruan
 - 3) Selaput lender mulut : : Tampak Kebiruan
 - 4) Lidah : Tidak ada kelainan.
- d. Telinga :
 - 1) Bentuk telinga : Tidak ada kelainan.



2) Permukaan daun telinga : Permukaan daun telinga Terdapat empat buah luka terbuka pada daun telinga kanan arah mendatar, sebelum dirapatkan bentuk menyerupai celah, setelah dirapatkan dapat rapat dengan sempurna membentuk garis lurus, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, tulang rawan, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak ada kelainan.

a) Luka pertama tepat pada tonjolan depan lubang telinga kanan, sebelum dirapatkan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang nol koma enam sentimeter

b) Luka kedua pada pertengahan daun telinga kanan, sebelum dirapatkan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang satu koma enam sentimeter.

c) Luka ketiga sejajar lubang telinga kanan, sebelum dirapatkan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang nol koma enam sentimeter

d) Luka keempat pada bagian bawah telinga yang hampir memutuskan bagian bawah daun telinga dengan tulang rawan telinga kanan, sebelum dirapatkan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma empat sentimeter, setelah dirapatkan ukuran panjang tiga koma enam sentimeter.

3) Lubang telinga : Tidak ada kelainan.

e. Alat Kelamin : Laki – laki.

1) Pelir / Penis : Sudah disunat.

2) Kantong Pelir : Tidak ada kelainan.

f. Dubur : Tidak ada kelainan.

12. Tulang – tulang :

a. Tulang tengkorak. Tampak patah tulang atap tengkorak sisi depan dan belakang kiri dan tulang rahang bawah.

b. Tulang belakang: Tidak ada kelainan



- c. Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- d. Tulang-tulang punggung Tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang pangkung : Tidak ada kelainan.
- f. Tulang anggota gerak. Tampak patah tulang hasta kanan bawah, tulang telapak tangan kanan, tulang hasta dan pengumpil kiri, tulang telapak tangan kiri, tulang ibu jari tangan kiri, tulang pergelangan kaki kanan dan kiri.

D. Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan.

E. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN / INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- 1) Telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun, ras mongoloid kesan gizi cukup.
- 2) Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada perut.
- 3) Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, wajah, mata, telinga, dada dan anggota gerak : Luka bacok pada kepala, wajah, telinga dan anggota gerak, patah tulang atap tengkorak, tulang rahang bawah, tulang hasta kanan bawah, tulang telapak tangan kanan, tulang hasta dan pengumpil kiri, tulang telapak tangan kiri, tulang ibu jari tangan kiri, tulang pergelangan kaki kanan dan kiri, putusnya tendon, pembuluh darah dan saraf pergelangan tangan kiri dan kedua pergelangan kaki.
- 4) Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat.
- E. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai pemeriksaan yang dilakukan namun diduga akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah pergelangan tangan kiri dan kedua pergelangan kaki sehingga mengakibatkan perdarahan hebat.-
- F. Waktu kematian diperkirakan antara dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan
- 7- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa sebagaimana termuat dalam Visum et repertum Psychiatricum Nomor : 445/1910/XI/VerP/2024 tanggal 08 November 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Nur Eddy, M.Kes.,Sp.KJ, Dokter pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada saat dilakukan pemeriksaan (wawancara dan observasi) di RS. Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, pada diri tersangka didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang



memenuhi kriteria diagnosis gangguan Skizofrenia Paranoid dengan diagnose banding Skizofrenia Tak Terinci

- b. Gangguan jiwa tersebut telah dan masih ada pada diri tersangka saat terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukannya
- c. **Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak berhubungan secara langsung dengan gangguan jiwa maupun gejala dari gangguan jiwa yang dialami oleh tersangka**
- d. Memenuhi unsur-unsur ketidakmampuan bertanggungjawab sebagian dimana tersangka menyadari perbuatannya, memahami nilai dan resiko dan akibat dari perbuatannya, namun tersangka tidak mampu memaksudkan tujuannya, tidak mampu mengarahkan kemauan dan tindakannya secara benar dan sadar sepenuhnya seperti orang normal pada umumnya oleh karena adanya gejala gangguan jiwa berat Skizofrenia Paranoid yang dialami oleh tersangka berupa Waham kejaran yang terpicu oleh adanya peristiwa sebelum terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa LAODE KUDU (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** terhadap Korban NAWIR. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 8- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Wakatobi menuju ke Kendari dan setibanya di Pelabuhan Nusantara Kendari, kemudian Terdakwa istirahat dan tidur di Pelabuhan Nusantara. Selanjutnya pada keesokan harinya, yakni pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WITA, Terdakwa bangun dan kemudian bertemu dengan Sdr. NARWIN (Alm) yang merupakan sopir mobil penumpang.
- 9- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa meminta kepada Sdr. NARWIN untuk mengantarnya ke Rumah Sakit Jiwa, sehingga terjadi tawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar antara Terdakwa dan Sdr. NARWIN dan sepakat biaya pengantarannya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Sdr. NAWIR.

- 10- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan, Terdakwa melihat jalan yang dilalui Sdr. NARWIN bukan merupakan jalan menuju Rumah Sakit Jiwa Kendari sehingga terjadi perdebatan mulut antara Terdakwa dan Sdr. NARWIN karena menurut Sdr. NARWIN, lokasi Rumah Sakit Jiwa sudah sesuai yakni berada di Jalan Dr. Sutomo Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari sehingga Sdr. NARWIN berhenti di pinggir jalan dan meminta kepada Terdakwa untuk keluar dari mobil.
- 11- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa keluar dari mobil, Sdr. NARWIN turun dari mobil dan memukul kepala Terdakwa menggunakan kayu sehingga Terdakwa merespons pukulan tersebut dengan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 38 (Tiga puluh delapan) Cm yang disimpan didalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut secara berulang kali sehingga mengenai tubuh Sdr. NARWIN dan mengakibatkan luka pada kepala, wajah, telinga dan anggota gerak, patah tulang atap tengkorak, tulang rahang bawah, tulang hasta kanan bawah, tulang telapak tangan kanan, tulang hasta dan pengumpil kiri, tulang telapak tangan kiri, tulang ibu jari tangan kiri, tulang pergelangan kaki kanan dan kiri, putusnya tendon, pembuluh darah dan saraf pergelangan tangan kiri dan kedua pergelangan kaki Sdr. NARWIN.
- 12- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi LAODE HARLIN dan Saksi MUH. DONI melihat dan membantu untuk mengamankan Terdakwa hingga pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian. Sedangkan Korban Sdr. NARWIN sudah tidak berdaya dan akhirnya meninggal ditempat sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor : B/15/VII/2024 tanggal 24 juli 2024 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa Dr. dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,MH,Sp.FM, MHPE, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang menerangkan benar bahwa Sdr. NARWIN telah dipastikan meninggal dunia sesuai pemeriksaan di ruang Kompartemen Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 09.30 WITA.
- 13- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 14/VII/2024/Forensik, tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. RAJA AL FATH WIDYA

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



ISWARA,MH,Sp.FM, MHPE Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun, ras mongoloid kesan gizi cukup.
- 2) Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada perut
- 3) Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, wajah, mata, telinga, dada dan anggota gerak : Luka bacok pada kepala, wajah, telinga dan anggota gerak, patah tulang atap tengkorak, tulang rahang bawah, tulang hasta kanan bawah, tulang telapak tangan kanan, tulang hasta dan pengumpil kiri, tulang telapak tangan kiri, tulang ibu jari tangan kiri, tulang pergelangan kaki kanan dan kiri, putusnya tendon, pembuluh darah dan saraf pergelangan tangan kiri dan kedua pergelangan kaki.
- 4) Didapatkan tanda-tanda perdarahan hebat.
- 5) Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti sesuai pemeriksaan yang dilakukan namun diduga akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah pergelangan tangan kiri dan kedua pergelangan kaki sehingga mengakibatkan perdarahan hebat.
- 6) Waktu kematian diperkirakan antara dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan

14-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa sebagaimana termuat dalam Visum et repertum Psychiatricum Nomor : 445/1910/XI/VerP/2024 tanggal 08 November 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Nur Eddy, M.Kes.,Sp.KJ, Dokter pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada saat dilakukan pemeriksaan (wawancara dan observasi) di RS. Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, pada diri tersangka didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang memenuhi kriteria diagnosis gangguan Skizofrenia Paranoid dengan diagnose banding Skizofrenia Tak Terinci
- b. Gangguan jiwa tersebut telah dan masih ada pada diri tersangka saat terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukannya
- c. **Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak berhubungan secara langsung dengan gangguan jiwa maupun gejala dari gangguan jiwa yang dialami oleh tersangka**



- d. Memenuhi unsur-unsur ketidakmampuan bertanggungjawab sebagian dimana tersangka menyadari perbuatannya, memahami nilai dan resiko dan akibat dari perbuatannya, namun tersangka tidak mampu memaksudkan tujuannya, tidak mampu mengarahkan kemauan dan tindakannya secara benar dan sadar sepenuhnya seperti orang normal pada umumnya oleh karena adanya gejala gangguan jiwa berat Skizofrenia Paranoid yang dialami oleh tersangka berupa Waham kejaran yang terpicu oleh adanya peristiwa sebelum terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harlini, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 15-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena meninggalnya suami dari Saksi, yaitu Korban Narwin akibat perbuatan Terdakwa;
 - 16-Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
 - 17-Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah tetangga Saksi yang bernama La Dilo menunjukkan handphonenya yang ada foto suami Saksi, di mana pada saat itu Saksi melihat jaket loreng yang dipakai oleh suami Saksi sehingga Saksi bisa memastikan bahwa benar itu suami dari Saksi;
 - 18-Bahwa saat kejadian meninggalnya suami dari Saksi, Saksi sedang berada di rumah Saksi tepatnya di Kelurahan Purirano;
 - 19-Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau alasan Terdakwa menghilangkan nyawa suami Saksi;
 - 20-Bahwa pada saat di Rumah Sakit Bhayangkara, Saksi sempat melihat jenazah suami dari Saksi tetapi Saksi tidak membukakan penutup jenazah karena Saksi tidak sanggup melihat, jadi Saksi tidak mengetahui di mana saja letak luka yang diderita oleh almarhun suami dari Saksi;
 - 21-Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa sebelumnya;



22-Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa menghilangkan nyawa suami Saksi, nanti setelah penyidik memberitahukan barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan parang pada saat menghilangkan nyawa suami dari Saksi;

23-Bahwa keluarga Terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Sampe Lintang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

24-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena meninggalnya Korban akibat perbuatan Terdakwa;

25-Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

26-Bahwa Saksi mengetahui kejadian berawal pada pukul 07.30 WITA Saksi tiba di sekitar tempat kejadian yang di mana pada saat itu sudah banyak orang berkumpul lalu Saksi turun dari mobil Saksi dan melihat jenazah yang ditutupi dan mendengar dari warga sekitar bahwa jenazah tersebut pekerjaannya sopir lalu Saksi mendekati jenazah dan Saksi mengenali bahwa itu teman Saksi sesama sopir yang bernama Narwin, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang saat itu sudah dalam posisi terikat dan Saksi langsung kenali Terdakwa yang Saksi temui di kapan Wanci dan Saksi sempat menawarkan jasa pengantaran kepada Terdakwa akan tetapi tidak jadi karena uang Terdakwa kurang lalu Saksi langsung menghubungi ketua Grab Pelabuhan Wanci untuk mengabarkan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Narwin;

27-Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, hanya melihat di rekaman video yang beredar di grup WhatsApp;

28-Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau alasan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban;

29-Bahwa jarak antara TKP dengan rumah sakit jiwa sekitar 200 (dua ratus) meter;

30-Bahwa Saksi mengabari teman-teman Saksi sesama pengemudi Maxim mengenai kejadian yang menimpa Korban;



- 31-Bahwa Saksi mengetahui melalui video yang beredar bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara mengayunkan parangnya dan menyerang korban;
- 32-Bahwa Saksi tidak sempat melihat luka yang ada pada tubuh Korban, melainkan hanya melihat muka korban;
- 33-Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa, Terdakwa sudah dalam posisi terikat diamankan warga sekitar;
- 34-Bahwa Saksi langsung mengenali Terdakwa yang Saksi temui di kapal Wanci dan Saksi sempat menawarkan jasa pengantaran kepada Terdakwa akan tetapi tidak jadi karena uang Terdakwa kurang;
- 35-Bahwa pada saat Saksi menawarkan jasa kepada Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan normal;
- 36-Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi berapa tarif menuju ke rumah sakit jiwa dan Saksi menjawab Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah_ tetapi saat itu tidak jadi karena uang Terdakwa tidak cukup;
- 37-Bahwa Saksi cukup kenal Korban dengan baik karena beberapa kali Saksi dan Korban minum kopi bersama dan Saksi dan Korban juga merupakan sesama pengemudi Maxim di area Pelabuhan Wanci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Nursalim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 38-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena meninggalnya Korban akibat perbuatan Terdakwa;
- 39-Bahwa Korban merupakan tetangga dari Saksi;
- 40-Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- 41-Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA saat Saksi sedang berada di Pelabuhan Jayanti Saksi mendapatkan telepon dari teman Saksi yang bernama Majid yang memberitahukan kepada Saksi untuk menyampaikan ke istri dari Korban bahwa Korban telah diparangi sampai meninggal;
- 42-Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk melihat kondisi Korban;



43-Bahwa Saksi melihat pada tubuh Korban terdapat banyak luka, di mana pada bagian kepala Korban pada bagian wajah terdapat bekas luka akibat benda tajam, pada bagian tangan kiri Korban telah putus, dan pada persendian belakang kedua kaki Korban juga telah putus akibat benda tajam;

44-Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Laode Harlin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

45-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena meninggalnya Korban akibat perbuatan Terdakwa;

46-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Saksi melintas dari arah pelelangan kota lama mau kembali ke rumah namun sesampai Saksi di TKP Saksi melihat kerumunan orang yang sementara melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban lalu saya memarkirkan kendaraan Saksi dan Saksi lihat Terdakwa memegang sebilah parang serta kondisi Korban sudah tidak bergerak sehingga Saksi berinisiatif untuk mencari celah pada saat Terdakwa membelakangi Saksi, Saksi kemudian mendatangi dan langsung memeluk Terdakwa namun Terdakwa masih bisa mengayunkan parang ke arah leher Saksi untuk melakukan perlawanan sehingga Saksi membantingnya dan kemudian datang Saudara Muh. Doni beserta warga lainnya dengan membawa kayu untuk membantu Saksi dengan cara memukul tangan Terdakwa sampai parang yang dia pegang terjatuh kemudian setelah itu warga langsung mengikat Terdakwa, tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

47-Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

48-Bahwa luka yang dialami Korban yaitu pergelangan tangan kiri putus, luka sobek pada dahi, pipi, badan, dan kaki kanan;

49-Bahwa saat Saksi tiba di TKP kondisi Korban saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia;



50-Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan parang untuk melakukan perbuatannya;

51-Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang parang dan kondisi Korban sudah tidak bergerak dan terlentang di jalan sehingga Saksi berinisiatif untuk mencari celah pada saat dia membelakangi Saksi, Saksi kemudian mendatangi dan langsung memeluk Terdakwa namun Terdakwa masih bisa mengayunkan parang ke arah leher Saksi untuk melakukan perlawanan sehingga Saksi membantingnya dan kemudian datang Saudara Muh. Doni beserta warga lainnya dengan membawa kayu untuk membantu Saksi dengan cara memukul tangan Terdakwa sampai parang yang dia pegang terjatuh kemudian setelah itu warga langsung mengikat Terdakwa;

52-Bahwa Saksi masih mengenali parang yang dipergunakan oleh Terdakwa;

53-Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak warga yang menyaksikan;

54-Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa tempat Saksi bekerja, sementara untuk Korban Saksi tidak mengenalnya;

55-Bahwa Saksi tidak mengerti penyebab dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban;

56-Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah dalam posisi terikat diamankan oleh warga sekitar;

57-Bahwa Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa tempat Saksi bekerja karena Saksi pernah berbincang dengan Terdakwa pada saat dia dirawat;

58-Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi dari rumah sakit jiwa tanpa sepengetahuan perawat ataupun petugas;

59-Bahwa pihak rumah sakit jiwa sudah berinisiatif melakukan pencarian saat Terdakwa pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Muh. Doni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

60-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena meninggalnya Korban akibat perbuatan Terdakwa;

61-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Tobuuha, Kecamatan



Puuwatu, Kota Kendari, Saksi melintas dari arah rumah sakit jiwa mau kembali ke rumah, namun sesampainya di TKP Saksi melihat kerumunan orang yang sementara melihat Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Korban kemudian Saksi memarkirkan kendaraan dan Saksi melihat Terdakwa menggunakan sebilah parang yang diayunkan ke arah tangan Korban hingga tangan dari Korban putus kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya kembali ke arah badan Korban secara berkali-kali hingga Korban tidak bergerak lagi, kemudian datang Saksi LAODE HARLIN yang pada saat itu dari arah belakang memeluk Terdakwa namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mengayunkan parang namun Saksi bersama warga lain datang membantu dengan membawa kayu untuk memukul tangan Terdakwa yang masih memegang parang, setelah parang Terdakwa jatuh kemudian Saksi bersama warga mengikat tangan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota polisi mengamankan dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;

62-Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

63-Bahwa luka yang dialami Korban yaitu pergelangan tangan kiri putus, luka sobek pada dahi, pipi, badan dan kaki kanan;

64-Bahwa kondisi Korban pada saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia di TKP;

65-Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan parang;

66-Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang parang dan mengayunkan parangnya berkali-kali ke arah tubuh Korban;

67-Bahwa Saksi masih mengenali parang yang dipergunakan oleh Terdakwa;

68-Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak warga yang menyaksikan;

69-Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ataupun Korban;

70-Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

71-Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah dalam posisi terikat diamankan oleh warga sekitar;

72-Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa;

73-Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat kejadian dalam keadaan jiwanya terganggu atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Nur Eddy, M. Kes., Sp.KJ., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

74-Bahwa sejak awal 2018 Ahli telah menekuni bidang keahlian dokter spesialis kedokteran jiwa dan Ahli juga pernah beberapa kali menjadi Ahli terkait tindak pidana dan melakukan pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Keterangan Ahli dan seluruhnya tidak memerlukan kehadiran di pengadilan sehingga belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli secara langsung di pengadilan;

75-Bahwa Ahli selaku dokter spesialis kejiwaan yang mengeluarkan hasil Visum Et Repertum Psychiatricum dan kemudian menandatangani Surat hasil Visum Et Repertum Psychiatricum tersebut terhadap diri Terdakwa;

76-Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Terdakwa menderita gangguan jiwa yang disebut dengan "skizofrenia paranoid" yaitu secara umum gangguan jiwa terbagi dua bagian besar gangguan jiwa ringan yaitu neurosis contohnya gangguan cemas, fobia, depresi, dan lain-lain, serta gangguan jiwa berat yaitu psikotik. Gangguan jiwa psikotik pada dasarnya ditandai dengan adanya gejala-gejala yang membuat seseorang berperilaku, berpikir, merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau dengan kata lain memiliki ketidakmampuan untuk berperilaku, berpikir, dan merasakan sesuatu yang sesuai dengan realitas/kenyataan/fakta yang sebenarnya. Contohnya seseorang yang tadinya normal kemudian menjadi sering berbicara sendiri, mendengar halusinasi, memiliki waham (keyakinan dalam pikiran yang salah), membiarkan dirinya telanjang di depan umum tanpa menyadarinya, berbicara yang aneh dan tidak masuk akal dan lain-lain. Salah satu gangguan jiwa psikotik yang berat adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan berbagai gejala klinis yang menyebabkan seseorang berpikir, berperilaku yang aneh dan tidak sesuai lagi dengan pikiran dan perilaku orang yang normal. Salah satu jenis skizofrenia adalah skizofrenia paranoid yang mana penderitanya memiliki gejala yang utama dan menonjol adalah adanya waham dan atau halusinasi, utamanya

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



halusinasi pendengaran. Penderita skizofrenia paranoid seringkali berpikir dan berperilaku dan merasakan sesuatu mengikuti waham yang dialaminya, misalnya penderita yang memiliki waham kejaran maka dia akan berpikir dan berperilaku bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang akan mencelakai, membunuh, mengawasi dirinya dan atau keluarganya sehingga menimbulkan rasa tidak aman yang menyebabkannya berperilaku mengamankan diri dengan misalnya selalu membawa senjata tajam, tidak tidur untuk mengintai sekeliling rumahnya, memasang pengaman pintu dan jendela berlebihan seperti yang dialami oleh Terdakwa. Seseorang yang memiliki waham kebesaran maka akan menyakini dan berperilaku bahwa ia adalah seorang tokoh penting seperti pejabat, utusan Tuhan atau nabi, dan lain-lain;

77-Bahwa gejala gangguan jiwa "waham kejaran" yaitu keyakinan yang salah yang tertanam kuat dalam pikiran seseorang yang menderita gangguan jiwa skizofrenia berupa adanya pikiran bahwa dirinya dan atau keluarganya akan dicelakai, dibunuh, ataupun hanya sekedar diikuti dan diawasi oleh seseorang atau sekelompok orang yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini membuat penderitanya akan mengalami perasaan "tidak aman" sehingga akan menimbulkan perilaku yang mengantisipasi rasa tidak aman tersebut dengan selalu membawa senjata tajam untuk melindungi dirinya, berjaga mengamati lingkungan sekitar rumahnya, mengganti atau menambah kunci pintu dan jendela secara berlebihan ataupun dapat menimbulkan sikap dan perilaku agresi yang dapat sampai taraf menyerang dan melukai seseorang yang diyakininya merupakan penyebab atau sumber yang akan mencelakai dirinya dan atau keluarganya;

78-Bahwa dari pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Terdakwa, Ahli mendapatkan adanya gejala waham kejaran yang telah berlangsung sejak Terdakwa kembali dari merantau di Sumatera sekitar awal tahun 2024 yang mana Terdakwa selalu merasa ketakutan seakan-akan ada yang mau mendatangi dirinya untuk berbuat jahat kepadanya sehingga Terdakwa mulai sering terlihat berperilaku aneh seperti mudah emosi dan kadang mengamuk, susah tidur, selalu was-was/khawatir dan kadang membawa senjata tajam. Namun, pada saat Ahli mencoba menghubungkan gejala gangguan jiwa waham kejaran tersebut dengan perbuatannya terhadap Korban, tidak terlihat hubungan yang secara



langsung bahwa Korban adalah salah seorang yang diyakini Terdakwa adalah seseorang yang akan mencelakainya sejak awal dan merupakan bagian langsung dari gejala waham kejaran Terdakwa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peristiwa dalam kurun waktu yang cukup dimana Terdakwa dan Korban melakukan transaksi antara penumpang taksi yang ingin menuju rumah sakit jiwa dengan Korban yang merupakan penyedia atau pelaku jasa angkutan taksi. Jika Korban adalah bagian dari seseorang yang diyakini Terdakwa adalah orang yang akan mencelakainya atau dengan kata lain merupakan bagian dari gejala waham kejarannya, maka Terdakwa sangat mungkin akan menghindar atau melakukan upaya untuk menyerang Korban saat itu juga. Begitupun saat dalam perjalanan dan tidak ditemukan adanya halusinasi pendengaran yang menyuruh, memberitahukan, memerintahkan Terdakwa selama dalam perjalanan bahwa Korban akan mencelakai dirinya dan menyuruhnya untuk melukai Korban;

79-Bahwa gejala waham kejaran Terdakwa dapat saja mendapatkan "pembenaran" setelah terjadinya peristiwa dimana Terdakwa merasa ditipu karena disuruh turun di tempat yang bukan rumah sakit jiwa yang selama kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hari mendapatkan perawatan dan kemudian diikuti dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Korban dengan menggunakan kayu kepada Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan marah dan secara spontan melakukan pemarkaran terhadap Korban. Waham kejaran yang dialami Terdakwa seperti mendapatkan pembuktian yang nyata bahwa memang benar dia sedang terancam. Waham kejaran yang dialami oleh Terdakwa yang menyebabkan adanya perasaan takut pada dirinya itulah yang menyebabkan hadirnya barang bukti sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa yang diambil dari kapal yang dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menjaga dirinya. Adapun pendapat ahli bahwa Terdakwa jelas memiliki gangguan jiwa berat skizofrenia paranoid dengan gejalanya berupa adanya waham kejaran. Namun, Terdakwa masih dapat merencanakan perjalanan dari tempat asalnya dengan menggunakan kapal ke Kendari untuk menuju rumah sakit jiwa untuk kembali berobat. Terdakwa juga memahami bahwa untuk ke rumah sakit jiwa yang ia tidak mengetahui jalan untuk kesana maka Terdakwa harus menggunakan jasa angkutan umum taksi yang telah sepakat dan membayar ongkosnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Pada pemeriksaan yang Ahli lakukan, Terdakwa memahami bahwa



dirinya telah diturunkan di tempat yang bukan tujuannya, menyadari dan memahami bahwa dirinya disuruh turun oleh Korban dan kemudian dipukul oleh Korban menggunakan kayu. Terdakwa juga memahami dan menyadari bahwa dirinya emosi dan marah serta menyadari dan memahami bahwa dirinya mengambil parang dalam tasnya kemudian menyerang dan memarangi Korban. Terdakwa juga menyatakan memahami risiko dan akibat dari perbuatannya yang dapat menyebabkan Korban cedera berat ataupun meninggal dunia dan Terdakwa mengatakan perbuatannya salah;

80-Bahwa menurut pendapat Ahli, Terdakwa disimpulkan memiliki ketidakmampuan bertanggung jawab sebagian atas perbuatannya atau kemampuan bertanggung jawab sebagian karena masih mampu menyadari perbuatannya, memahami nilai dan risiko serta akibat dari perbuatannya namun sebagian atau tidak sepenuhnya oleh karena adanya gangguan jiwa yang dialaminya dengan gejala waham kejaran yang dialaminya yang seperti terpicu akibat merasa ditipu dan di pukul oleh Korban yang menyebabkannya emosi dan marah serta secara spontan menyerang Korban dengan menggunakan parang yang dibawanya menyebabkan Terdakwa tidak mampu untuk memaksudkan tujuannya, tidak mampu mengarahkan kemauannya dan tindakannya secara benar dan sadar sepenuhnya. Yang menurut Ahli juga penting adalah dengan adanya gejala waham kejaran yang dialaminya tersebut menyebabkan hadirnya barang bukti sebilah parang yang diambilnya yang bukan miliknya yang dimaksudkan untuk menjaga dirinya, sebuah benda yang tidak bernilai ekonomis yang signifikan yang jika saja Terdakwa tidak memiliki waham kejaran tersebut, maka sebilah parang tersebut tidak akan dan tidak perlu untuk diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Ahli dan tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli Dr. Handrawan, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

81-Bahwa sebelumnya Ahli sudah memberikan keterangan sebagai Ahli di dalam perkara Pidana sebanyak 10 (sepuluh) perkara yaitu perkata tindak pidana umum dan perkara tindak pidana korupsi;

82-Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Unaaha tetapi terkait dengan tindak pembakaran yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;



83-Bahwa dalam konsep hukum pidana, orang yang melakukan tindak pidana belum pantas diajtuhi pidana tetapi terlebih dahulu harus dilihat dulu proses pertanggungjawaban pidananya terlebih dahulu karena itu merupakan pintu masuk untuk menentukan apakah seseorang itu dapat dipidana atau tidak. Di dalam doktrin pertanggungjawaban hukum pidana bicara 2 (dua) hal yang pertama terkait dengan kesalahan dan yang kedua terkait aspek penghapus pidana atau aspek penghapus pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan kesalahan belum tentu dapat dipidana. Di dalam hukum pidana di Indonesia, ada beberapa orang yang melakukan tindak pidana tidak patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana yang pertama termuat dalam Pasal 44 KUHP yakni orang gila, yang kedua adalah *overmacht* atau keadaan memaksa dan yang ketiga adalah perintah undang-undang, itu adalah golongan yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

84-Bahwa cikal bakal sehingga lahirnya Pasal 44 KUHP, yaitu hukum pidana dibagi dalam 3 (tiga) fase, ada fase hukum pidana kuno, hukum pidana abad pertengahan, dan hukum pidana abad modern. Dalam hukum pidana kuno, semangat yang terbangun adalah semangat penghukuman tanpa mempertimbangkan keadaan kejiwaan-kejiwaan pelaku, konsep ini kemudian mengalami evolusi di zaman Romawi, di mana zaman itu Furiosus adalah orang dengan gangguan mental tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana kemudian di zaman Prancis di dalam kode penalnya konsepsi orang gila atau cacat mental sebagai alasan penghapus pidana, sistem hukum anglo-saxon ataupun eropa kontinental bersepakat bahwa orang gila tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan Kesimpulan dari Ahli kejiwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa disimpulkan memiliki ketidakmampuan bertanggung jawab sebagian atas perbuatannya atau kemampuan bertanggung jawab sebagian karena masih mampu menyadari perbuatannya, memahami nilai dan risiko serta akibat dari perbuatannya namun sebagian atau tidak sepenuhnya oleh karena adanya gangguan jiwa yang dialaminya, didalam hukum pidana tidak dikenal adanya pertanggungjawaban sebagian, di dalam pertanggung jawaban itu ada 2 (dua) bagian yaitu pertanggungjawaban penuh dan pertanggungjawaban yang dikecualikan, dalam hal apa pertanggungjawaban pidana dalam alasan penghapus pidana bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana yang sifatnya dikurangi atau



kemudian orang yang melakukan perbuatan itu masih menyadari sebagian, kalau dia masih menyadari tindakan yang dilakukannya pada saat melakukan perbuatan itu maka itu dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagian, dalam rancangan KUHP baru penyakit skizofrenia dan bipolar sudah masuk dalam gangguan jiwa berat, yang bisa dikurangi pertanggungjawabannya adalah yang menderita *down syndrome*, menurut hemat Ahli sebagai seorang Ahli Pidana keadaan Terdakwa menjadi alasan untuk penghapusan pidana;

85-Bahwa pertanggungjawaban yang dikecualikan itu kalau yang melakukan tindak pidana merupakan tuna grahita, *down syndrome*, akan tetapi orang yang masih menyadari sebagian dari perbuatan yang dilakukannya, *eye contact*-nya masih bagus, jawabannya juga saat ditanya masih bagus itu yang dinamakan pertanggungjawaban yang dikecualikan terkait dengan cacat mental;

86-Bahwa menurut pengamatan Ahli secara langsung saat Terdakwa di persidangan, tatapan mata Terdakwa, Terdakwa berbicara sendiri, Terdakwa adalah orang yang cacat mentalnya atau dengan kata lain orang gila;

87-Bahwa kalau dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum menurut dari pendapat Ahli kejiwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa cacat mental tetapi masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasar dari frasa pertanggungjawaban sebagian itu perkara ini bisa berlanjut kalau menurut Ahli, dokter ahli jiwa cukup menjelaskan mengenai kejiwaan Terdakwa, jangan menambahkan frasa bertanggung jawab sebagian yang dapat menimbulkan pengertian yang berbeda;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Ahli dan tidak keberatan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: VeR /14/VII/2024/Forensik tanggal 24 Juli 2024 atas nama NARWIN yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Kendari yang dibuat oleh Dr. dr. Raja Al Fath Widya Iswara , M.H.,Sp.FM., MHPE selaku dokter ahli forensik;
2. Surat keterangan kematian Nomor : B/15/VII/2024 tanggal 24 juli 2024 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa Dr. dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,MH,Sp.FM, MHPE, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang menerangkan benar bahwa Sdr. NARWIN telah dipastikan meninggal dunia sesuai pemeriksaan di ruang Kompartemen Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 09.30 WITA;

3. Surat Visum et repertum Psychiatricum Nomor : 445/1910/XI/VeRP/2024 tanggal 08 November 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Nur Eddy, M.Kes.,Sp.KJ, Dokter pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 88-Bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban;
- 89-Bahwa Terdakwa tidak tahu dihadirkan di persidangan untuk masalah apa;
- 90-Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan terhadap Korban;
- 91-Bahwa kejadiannya di Mandonga pagi hari saat Terdakwa dari pelabuhan;
- 92-Bahwa saat itu Terdakwa akan pergi ke rumah sakit jiwa;
- 93-Bahwa sebelumnya Terdakwa dari Wanci;
- 94-Bahwa parang diperoleh Terdakwa dari kapal Wanci lalu Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa;
- 95-Bahwa parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa karena Terdakwa merasa ketakutan jangan sampai ada yang memukul Terdakwa;
- 96-Bahwa Terdakwa merasa ada yang mengikuti Terdakwa;
- 97-Bahwa Terdakwa memarangi Korban karena Korban memukul kepala Terdakwa menggunakan kayu;
- 98-Bahwa Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 99-Bahwa setelah Korban memukul kepala Terdakwa, Terdakwa mengambil parang di dalam tas dan langsung memarangi Korban;
- 100- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sadar karena emosi;
- 101- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat;
- 102- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa mengayunkan parang ke tubuh korban;
- 103- Bahwa Terdakwa tidak tahu tempat kejadian tersebut dekat dengan rumah sakit jiwa;
- 104- Bahwa Terdakwa sakit jiwa dan sering mengalami sakit kepala;
- 105- Bahwa Terdakwa mengetahui perbedaan rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa;
- 107- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah sakit jiwa dan pulang ke kampung karena rindu dengan orang tua;
- 108- Bahwa Terdakwa pernah dikunjungi oleh sepupunya dari Morowali;
- 109- Bahwa saat ke Wanci Terdakwa bertemu dengan orang tua tetapi disuruh kembali ke Kendari;
- 110- Bahwa Terdakwa tidak membawa obat saat keluar dari rumah sakit jiwa sehingga Terdakwa tidak bisa tidur;
- 111- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui Terdakwa pulang kembali ke Kendari;
- 112- Bahwa orang tua Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa untuk transport ke rumah sakit jiwa;
- 113- Bahwa Terdakwa selalu didampingi berobat kecuali saat kejadian Terdakwa pergi sendiri;
- 114- Bahwa Terdakwa memarangi Korban saat turun dari mobil, kepala Terdakwa dipukul juga setelah turun dari mobil;
- 115- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung ditangkap;
- 116- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa belum sampai di tujuan Terdakwa diturunkan;
- 117- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat Terdakwa diturunkan oleh Korban;
- 118- Bahwa Terdakwa dirawat selama 2 (dua) bulan di rumah sakit jiwa;
- 119- Bahwa obat yang Terdakwa konsumsi tidak bisa mengatasi penyakit Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa tidur;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 30 (Tiga puluh delapan) cm;
2. 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kuning terdapat darah yang mengering;
4. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dalaman merah terdapat darah yang mengering;
5. 1 (satu) lembar singlet warna putih terdapat darah yang mengering;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar jaket motif loreng dan warna abu-abu pada bagian dalam terdapat darah yang mengering;

8. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya Korban di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

2. Bahwa Korban meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa mengayunkan parang secara berulang kali terhadap Korban;

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan awalnya Terdakwa merupakan penumpang taksi yang dikemudikan oleh Korban, lalu Terdakwa diturunkan tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yakni Rumah Sakit Jiwa Kendari, kemudian Korban memukuli Terdakwa menggunakan kayu sehingga Terdakwa merespon dengan mengambil parang di dalam tas yang ia bawa lalu mengayunkannya berkali-kali kepada Korban;

4. Bahwa Terdakwa memperoleh parang dari kapal di Wanci dan menyimpannya di dalam tas sebagai alat perlindungan diri karena merasa terus diawasi dan dikejar oleh seseorang;

5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 445/1910/XI/VeRP/2024 tanggal 08 November 2024, Terdakwa didiagnosis mengalami gangguan jiwa berat, yaitu skizofrenia paranoid, yang ditandai dengan gejala waham kejaran dan perilaku tidak sesuai dengan kenyataan;

6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VeR/14/VII/2024/Forensik tanggal 24 Juli 2024, korban mengalami luka-luka akibat benda tajam yang menyebabkan kematiannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan hukum menunjuk kepada setiap orang yang menjadi subjek hukum, baik sebagai individu (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), yang dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana serta memiliki kapasitas hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri saling bersesuaian dan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah Terdakwa atas nama **LAODE KUDU** beserta identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Teori *MVT* yang menyatakan bahwa apabila unsur Kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan suatu tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus pula ditujukan pada semua unsur-unsur pasal yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182), sehingga sesuai dengan hal tersebut unsur “dengan sengaja” disatukan dengan unsur “merampas nyawa orang lain” sehingga menjadi “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka pembuktian unsur tersebut harus dititikberatkan pada unsur “dengan sengaja” karena apabila unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi, maka seluruh unsur yang ada di belakangnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa kesengajaan berhubungan dengan niat (*mens rea*) yang merupakan sikap batin pelaku tindak pidana, di mana dalam pembuktiannya terdapat kesulitan dikarenakan terbatasnya alat bukti yang dapat secara langsung menunjukkan keadaan mental pelaku sehingga sikap batin pelaku tindak pidana harus disimpulkan berdasarkan keadaan konkrit yang terlihat dari luar dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan secara objektif;

Menimbang bahwa terdapat 3 (tiga) macam kesengajaan sebagai berikut:



1. Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, yang berarti bahwa akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan pelaku adalah merupakan maksud atau tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran, yang berarti bahwa ketika pelaku melakukan sesuatu perbuatan, ia menyadari akan terjadinya akibat tertentu tetapi ia tetap melakukan perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yang berarti bahwa risiko yang diketahui kemungkinan akan terjadi sungguh-sungguh timbul di samping hal yang dimaksud oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka apabila seseorang menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka orang tersebut dapat dianggap mempunyai kesengajaan terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa tindak pidana dalam unsur ini, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240, disebut sebagai makar mati atau pembunuhan (*doodslag*), yang mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sehingga unsur pasal ini lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa atau matinya seseorang, tanpa mempersoalkan cara maupun alat yang digunakan, meskipun secara umum dapat dimaklumi bahwa cara serta alat yang dipakai untuk mencapai akibat tersebut harus memiliki sifat mematikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;

Menimbang bahwa mati adalah “sudah hilang nyawanya”, “tidak bernyawa”, “tidak pernah hidup”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan keyakinan hakim, diperoleh fakta hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WITA telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya Korban di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang bahwa Korban meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa mengayunkan parang secara berulang kali terhadap Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan awalnya Terdakwa merupakan penumpang taksi yang dikemudikan oleh Korban, lalu Terdakwa diturunkan tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Jiwa Kendari, kemudian Korban memukuli Terdakwa menggunakan kayu sehingga Terdakwa merespon dengan mengambil parang di dalam tas yang ia bawa lalu mengayunkannya berkali-kali kepada Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh parang dari kapal di Wanci dan menyimpannya di dalam tas sebagai alat perlindungan diri karena merasa terus diawasi dan dikejar oleh seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VeR/14/VII/2024/Forensik tanggal 24 Juli 2024, korban mengalami luka-luka akibat benda tajam yang menyebabkan kematiannya;

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur pasal yang didakwakan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban dengan cara mengayunkan parang secara berulang kali ke arah Korban dan mengakibatkan luka iris pada beberapa bagian tubuh, khususnya pada bagian pembuluh darah pergelangan tangan kiri dan kedua pergelangan kaki yang terpotong sehingga mengakibatkan peredaran hebat, di mana parang yang digunakan oleh Terdakwa diperoleh dari kapal di Wanci dengan maksud untuk melindungi dirinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan di sini dapat dilihat secara objektif dari tindakan Terdakwa yang membawa parang untuk membela diri, di mana berarti bahwa Terdakwa sadar bahwa parang itu sendiri memiliki sifat mematikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait adanya alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan pembeda diatur di dalam Pasal 50 KUHP, yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Sehingga yang dimaksud dengan alasan pembeda ialah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana dan dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Sedangkan alasan pemaaf

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Sehingga yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum dan dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif);

Menimbang bahwa selanjutnya Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena:

- a. Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir;
- b. Sakit berubah akalnya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri, epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa dalam menilai dapat tidaknya seorang Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan kondisi kejiwaannya, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan guna memperoleh kepastian mengenai kondisi psikologis terdakwa, hakim dapat meminta pendapat ahli, termasuk dokter spesialis kejiwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diperiksa kejiwaannya oleh Ahli Kejiwaan Dr. Nur Eddy, M.Kes.,Sp.KJ, di mana Ahli telah mengeluarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 445/1910/XI/VerP/2024 tanggal 08 November 2024, yang menyatakan bahwa Terdakwa didiagnosis mengalami gangguan jiwa berat, yaitu skizofrenia paranoid, yang ditandai dengan gejala waham kejaran dan perilaku tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa sering sekali berbicara sendiri, dan tidak mampu menjawab secara jelas layaknya orang biasa, khususnya ketika terhadapnya diajukan pertanyaan yang panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menempatkan Terdakwa di dalam Rumah Sakit Jiwa Kendari, dengan masa perawatan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 30 (Tiga puluh delapan) cm, 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kuning terdapat darah yang mengering, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dalaman merah terdapat darah yang mengering, 1 (satu) lembar singlet warna putih terdapat darah yang mengering, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar jaket motif loreng dan warna abu-abu pada bagian dalam terdapat darah yang mengering, dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

120- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

121- Terdakwa merupakan orang pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Laode Kudu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan tindakan terhadap Terdakwa dengan cara memasukkan Terdakwa dalam Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun sampai dengan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 38 (Tiga puluh delapan) Cm;
 2. 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna kuning terdapat darah yang mengering;
 4. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dalaman merah terdapat darah yang mengering;
 5. 1 (satu) lembar singlet warna putih terdapat darah yang mengering;
 6. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 7. 1 (satu) lembar jaket motif loreng dan warna abu-abu pada bagian dalam terdapat darah yang mengering;
 8. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh Resky AP Bunggasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.



Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh Resky AP Bunggasi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)